

# GAP ANALYSIS

## Sistem Informasi Rabbit Clinic and Care

---

### 1. Pendahuluan

Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pelayanan Rabbit Clinic and Care saat ini dengan kondisi yang diharapkan setelah sistem RabbitCare diterapkan.

Kondisi saat ini menggambarkan proses yang masih banyak dilakukan secara manual, menggunakan buku pencatatan, dokumen terpisah, spreadsheet, telepon, atau aplikasi pesan seperti WhatsApp. Kondisi target menggambarkan proses pelayanan yang telah terintegrasi melalui sistem informasi RabbitCare.

Analisis ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kelemahan proses pelayanan saat ini.
  2. Menentukan kebutuhan perubahan proses bisnis.
  3. Menilai kesiapan klinik dalam menerapkan sistem.
  4. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui SWOT.
  5. Menemukan akar penyebab permasalahan menggunakan Fishbone Analysis.
  6. Menentukan prioritas pengembangan dan strategi implementasi sistem.
- 

## 2. Kondisi Saat Ini dan Kondisi Target

### 2.1 Kondisi Saat Ini atau As-Is

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, kondisi pelayanan saat ini diasumsikan memiliki karakteristik berikut:

- Booking dilakukan melalui WhatsApp, telepon, atau datang langsung.
- Jadwal dokter dan groomer dicatat secara manual.
- Data pemilik dan kelinci tersimpan pada buku, spreadsheet, atau dokumen yang berbeda.
- Riwayat kesehatan belum tersimpan dalam satu sistem terpusat.
- Catatan grooming belum terhubung dengan data medis.
- Pemilik mengandalkan ingatan atau catatan pribadi untuk jadwal kontrol.
- Reminder dikirim secara manual oleh petugas.
- Proses check-in dan antrian belum terkelola secara sistematis.
- Tagihan dihitung berdasarkan catatan layanan secara manual.
- Laporan kunjungan dan pendapatan disusun dengan merekap ulang data.
- Hak akses data belum dibedakan secara sistematis.
- Perubahan data belum memiliki audit trail yang jelas.

## 2.2 Kondisi Target atau To-Be

Setelah RabbitCare diterapkan, kondisi yang diharapkan adalah:

- Pemilik dapat melakukan booking secara mandiri.
- Sistem menampilkan jadwal dokter dan groomer yang tersedia.
- Setiap kelinci memiliki profil dan nomor rekam medis unik.
- Data pasien, booking, pelayanan, dan pembayaran tersimpan dalam database terpusat.
- Dokter dapat mengakses riwayat kesehatan pasien.
- Groomer dapat mencatat kondisi awal, hasil grooming, dan temuan kesehatan.
- Groomer dapat membuat rujukan kepada dokter.
- Sistem menghasilkan nomor antrean ketika pasien check-in.
- Sistem membuat tagihan berdasarkan layanan dan obat yang diberikan.
- Pemilik menerima reminder kontrol, vaksinasi, pemberian obat, dan grooming.
- Manajer dapat melihat laporan operasional melalui dashboard.
- Setiap pengguna memiliki hak akses berdasarkan perannya.
- Perubahan data penting dicatat melalui audit log.

## 3. Matriks Gap Analysis

| No. | Area Proses        | Kondisi Saat Ini                                          | Kondisi Target                             | Kesenjangan                            | Dampak                                        | Prioritas     |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1   | Registrasi pemilik | Data dicatat manual atau melalui pesan                    | Pemilik membuat akun secara mandiri        | Belum ada mekanisme registrasi digital | Data tidak konsisten dan mudah duplikat       | Tinggi        |
| 2   | Profil kelinci     | Data kelinci tersebar di berbagai catatan                 | Setiap kelinci memiliki profil dan ID unik | Tidak tersedia data pasien terpusat    | Riwayat pasien sulit ditelusuri               | Sangat Tinggi |
| 3   | Booking            | Dilakukan melalui WhatsApp, telepon, atau datang langsung | Booking dilakukan melalui sistem           | Belum ada booking terstruktur          | Risiko kesalahan dan keterlambatan konfirmasi | Sangat Tinggi |
| 4   | Jadwal petugas     | Jadwal dokter dan groomer dicatat manual                  | Jadwal tersedia secara real-time           | Tidak ada sinkronisasi jadwal          | Risiko benturan jadwal dan double booking     | Sangat Tinggi |

| No. | Area Proses     | Kondisi Saat Ini                                      | Kondisi Target                                  | Kesenjangan                               | Dampak                                            | Prioritas     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 5   | Check-in        | Kedatangan dicatat manual                             | Admin melakukan check-in melalui sistem         | Tidak ada pencatatan status kedatangan    | Antrean sulit dipantau                            | Tinggi        |
| 6   | Antrean         | Antrean disampaikan secara lisan                      | Sistem menghasilkan nomor antrean               | Tidak tersedia queue management           | Pelayanan kurang teratur                          | Tinggi        |
| 7   | Rekam medis     | Catatan pemeriksaan terpisah atau berbentuk kertas    | Rekam medis tersimpan secara digital            | Tidak ada integrasi riwayat pemeriksaan   | Dokter sulit melihat riwayat sebelumnya           | Sangat Tinggi |
| 8   | Vaksinasi       | Catatan vaksin dan jadwal berikutnya dilakukan manual | Data vaksin dan reminder tersimpan otomatis     | Belum ada pengelolaan vaksin terstruktur  | Jadwal vaksin berpotensi terlewat                 | Tinggi        |
| 9   | Grooming        | Hasil grooming tidak selalu terdokumentasi            | Hasil dan temuan grooming dicatat               | Tidak ada riwayat grooming terintegrasi   | Temuan kesehatan berpotensi tidak ditindaklanjuti | Tinggi        |
| 10  | Rujukan groomer | Disampaikan secara lisan kepada pemilik               | Rujukan dibuat dan dicatat dalam sistem         | Tidak ada alur rujukan resmi              | Informasi temuan dapat hilang                     | Tinggi        |
| 11  | Tagihan         | Biaya dihitung dari catatan layanan                   | Tagihan dibuat otomatis berdasarkan transaksi   | Belum ada integrasi pelayanan dan billing | Risiko salah hitung dan transaksi tidak tercatat  | Sangat Tinggi |
| 12  | Pembayaran      | Bukti pembayaran disimpan secara manual               | Status pembayaran dan bukti transaksi tersimpan | Belum ada histori pembayaran terpusat     | Laporan keuangan sulit direkonsiliasi             | Tinggi        |

| No. | Area Proses         | Kondisi Saat Ini                                     | Kondisi Target                            | Kesenjangan                                       | Dampak                                          | Prioritas     |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 13  | Reminder            | Petugas mengingatkan secara manual                   | Reminder dikirim otomatis                 | Belum tersedia scheduler dan notification service | Kontrol dan perawatan dapat terlewat            | Sangat Tinggi |
| 14  | Laporan             | Data direkap ulang                                   | Laporan tersedia dari database            | Tidak tersedia laporan otomatis                   | Evaluasi membutuhkan waktu lama                 | Sedang        |
| 15  | Hak akses           | Semua data berpotensi diakses oleh petugas yang sama | Akses dibedakan berdasarkan role          | Belum ada role-based access control               | Risiko perubahan dan kebocoran data             | Sangat Tinggi |
| 16  | Audit perubahan     | Perubahan data tidak tercatat                        | Perubahan penting memiliki audit log      | Belum ada keterlacakan perubahan                  | Sulit mengetahui pihak yang mengubah data       | Tinggi        |
| 17  | Infrastruktur       | Bergantung pada perangkat dan proses manual          | Sistem berbasis web dan database          | Belum tersedia infrastruktur aplikasi             | Implementasi memerlukan investasi dan pelatihan | Tinggi        |
| 18  | Kompetensi pengguna | Petugas terbiasa menggunakan proses manual           | Petugas menggunakan aplikasi sesuai peran | Ada kesenjangan kemampuan digital                 | Risiko penolakan dan kesalahan penggunaan       | Tinggi        |

## 4. Ringkasan Gap Utama

Berdasarkan matriks tersebut, kesenjangan utama Rabbit Clinic and Care dapat dikelompokkan menjadi enam bagian.

### 4.1 Gap Integrasi Data

Data pemilik, kelinci, pemeriksaan, grooming, vaksinasi, dan pembayaran belum disimpan pada satu sumber data yang sama.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan:

- Data ganda.
- Data tidak konsisten.
- Riwayat pasien tidak lengkap.
- Kesulitan menemukan informasi lama.
- Kesalahan dalam menghubungkan pasien dengan transaksi.

Kebutuhan perubahan adalah pembangunan database terpusat yang menghubungkan data pemilik, kelinci, booking, layanan, dan pembayaran.

## 4.2 Gap Pengelolaan Pelayanan

Proses booking, check-in, antrean, dan penyelesaian layanan belum memiliki status yang terstruktur.

Sistem perlu menyediakan status pelayanan seperti:

Menunggu Konfirmasi  
Terkonfirmasi  
Check-in  
Menunggu Antrean  
Sedang Dilayani  
Selesai Dilayani  
Belum Dibayar  
Lunas  
Dibatalkan  
Dijadwalkan Ulang  
Tidak Hadir

## 4.3 Gap Kesiambungan Perawatan

Hubungan antara hasil pemeriksaan, vaksinasi, grooming, kontrol, dan reminder belum terintegrasi.

Sistem perlu secara otomatis menghasilkan jadwal tindak lanjut berdasarkan:

- Jadwal kontrol dokter.
- Jadwal vaksinasi berikutnya.
- Jadwal grooming.
- Jadwal pemberian obat.
- Rekomendasi pemeriksaan ulang.

## 4.4 Gap Akurasi dan Keterlacakan

Proses manual belum menjamin bahwa setiap perubahan data dapat diketahui sumbernya.

Sistem perlu menyediakan:

- ID transaksi unik.
- Nomor rekam medis unik.
- Nomor booking unik.
- Timestamp pencatatan.
- Identitas pengguna yang melakukan perubahan.
- Audit log.

## 4.5 Gap Efisiensi Operasional

Petugas masih harus mencari, mencatat, dan merekap ulang data.

Sistem perlu mengurangi aktivitas berulang melalui:

- Pencarian pasien otomatis.
- Penjadwalan digital.
- Perhitungan tagihan otomatis.
- Reminder otomatis.
- Dashboard laporan.

## 4.6 Gap Kompetensi dan Adopsi

Perubahan dari proses manual ke sistem digital dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna internal.

Kesenjangan tersebut perlu ditangani melalui:

- Pelatihan.
- Panduan penggunaan.
- Tampilan sederhana.
- Pembagian hak akses yang jelas.
- Uji coba bertahap.
- Pendampingan pada awal implementasi.

---

# 5. Analisis SWOT

## 5.1 Strengths atau Kekuatan

Kekuatan internal RabbitCare meliputi:

### 1. Fokus pada kelinci

Sistem dirancang khusus untuk klinik dan perawatan kelinci, sehingga lebih relevan dibandingkan sistem klinik hewan yang terlalu umum.

#### **1. Integrasi layanan medis dan perawatan**

Pemeriksaan dokter, vaksinasi, grooming, pembayaran, dan reminder berada dalam satu sistem.

#### **1. Pemahaman proses bisnis nyata**

Pengembangan sistem didukung oleh pengalaman langsung terhadap aktivitas Rabbit Clinic and Care.

#### **1. Riwayat pasien terpusat**

Setiap kelinci memiliki profil dan rekam layanan yang saling terhubung.

#### **1. Reminder otomatis**

Sistem membantu mengurangi kemungkinan kontrol dan perawatan terlewat.

#### **1. Pemisahan hak akses**

Admin, dokter, groomer, manajer, dan pemilik memiliki akses sesuai tanggung jawabnya.

#### **1. Validasi layanan khusus**

Terdapat pemeriksaan pra-vaksin dan pemeriksaan keamanan sebelum grooming.

#### **1. Mendukung keputusan operasional**

Data pelayanan dapat digunakan untuk menghasilkan laporan klinik.

## **5.2 Weaknesses atau Kelemahan**

Kelemahan internal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Produk masih berada pada tahap perancangan.
2. Belum diuji pada operasional klinik secara penuh.
3. Pengguna internal mungkin belum terbiasa menggunakan sistem digital.
4. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada ketepatan input petugas.
5. Sistem awal masih berfokus pada satu klinik.
6. Fitur laboratorium dan rawat inap belum tersedia.
7. Integrasi payment gateway belum menjadi fitur utama.
8. Sistem membutuhkan koneksi internet yang stabil.
9. Biaya pembangunan, hosting, dan pemeliharaan perlu disiapkan.
10. Data lama perlu dimigrasikan atau dimasukkan kembali.

## 5.3 Opportunities atau Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi:

1. Penerapan sistem pada klinik kelinci lain.
2. Pengembangan menjadi sistem berbasis langganan.
3. Pengembangan fitur multi-cabang.
4. Integrasi dengan WhatsApp untuk reminder.
5. Kerja sama dengan komunitas kelinci.
6. Pengembangan modul nutrisi dan perkembangan berat badan.
7. Pengembangan aplikasi mobile.
8. Integrasi dengan pet shop atau layanan perawatan.
9. Pengembangan loyalty program.
10. Pengembangan layanan konsultasi jarak jauh pada tahap berikutnya.

## 5.4 Threats atau Ancaman

Ancaman eksternal yang mungkin dihadapi meliputi:

1. Penolakan pengguna terhadap perubahan proses kerja.
2. Kompetisi dengan sistem klinik hewan yang sudah tersedia.
3. Gangguan layanan internet atau server.
4. Kegagalan layanan notifikasi eksternal.
5. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data.
6. Biaya layanan WhatsApp atau provider notifikasi.
7. Perubahan jadwal dokter yang mendadak.
8. Kesalahan input data medis oleh pengguna.
9. Ketergantungan pada penyedia hosting.
10. Sistem ditinggalkan apabila tidak mudah digunakan.

---

# 6. Matriks Strategi SWOT

## 6.1 Strategi Strength–Opportunity atau SO

Strategi SO menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

| Kekuatan                  | Peluang                                     | Strategi                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fokus khusus pada kelinci | Potensi penggunaan oleh klinik kelinci lain | Mengembangkan RabbitCare sebagai solusi khusus rabbit clinic |
| Data terintegrasi         | Pengembangan multi-cabang                   | Menyiapkan struktur database yang mendukung cabang           |



| Kekuatan                   | Peluang                      | Strategi                                                |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Reminder otomatis          | Integrasi WhatsApp           | Mengembangkan notification service multi-channel        |
| Riwayat perawatan terpusat | Kerja sama komunitas kelinci | Menyediakan fitur edukasi dan riwayat kesehatan digital |
| Pemisahan peran            | Model langganan klinik       | Menyediakan paket pengguna berdasarkan jumlah staf      |

## 6.2 Strategi Strength–Threat atau ST

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.

| Kekuatan                   | Ancaman                             | Strategi                                            |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alur khusus kelinci        | Kompetisi dengan sistem klinik umum | Menonjolkan fitur pra-vaksin, grooming, dan rujukan |
| Role-based access          | Risiko kebocoran data               | Membatasi akses berdasarkan tugas                   |
| Riwayat terpusat           | Kesalahan informasi pasien          | Menambahkan validasi dan audit log                  |
| Reminder terintegrasi      | Kegagalan provider                  | Menyediakan retry dan alternatif kanal              |
| Flow pelayanan terstruktur | Perubahan jadwal mendadak           | Menyediakan reschedule dan notifikasi perubahan     |

## 6.3 Strategi Weakness–Opportunity atau WO

Strategi WO memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan.

| Kelemahan                    | Peluang                         | Strategi                                                  |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produk belum diuji           | Pilot pada satu klinik          | Melakukan implementasi bertahap                           |
| Fitur masih terbatas         | Pengembangan modul tambahan     | Menyusun roadmap berdasarkan prioritas                    |
| Belum mendukung multi-cabang | Potensi ekspansi                | Menyiapkan desain arsitektur scalable                     |
| Pengguna belum terbiasa      | Komunitas dan jaringan klinik   | Mengadakan pelatihan dan uji penggunaan                   |
| Belum ada aplikasi mobile    | Tingginya penggunaan smartphone | Mengembangkan mobile-responsive interface terlebih dahulu |

## 6.4 Strategi Weakness–Threat atau WT

Strategi WT bertujuan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman.

| Kelemahan               | Ancaman                             | Strategi                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ketergantungan internet | Gangguan koneksi                    | Menambahkan retry, autosave, dan prosedur darurat manual |
| Ketepatan input rendah  | Kesalahan data medis                | Menggunakan validasi form dan field wajib                |
| Produk masih baru       | Penolakan pengguna                  | Melakukan onboarding dan pilot testing                   |
| Biaya implementasi      | Klinik tidak melanjutkan penggunaan | Memulai dari MVP dengan fitur paling penting             |
| Migrasi data lama       | Data pasien tidak lengkap           | Melakukan validasi data dan migrasi bertahap             |

## 7. Kesimpulan SWOT

Hasil SWOT menunjukkan bahwa RabbitCare memiliki kekuatan utama pada spesialisasi layanan kelinci dan integrasi alur pelayanan. Kekuatan tersebut dapat menjadi pembeda dibandingkan sistem klinik hewan umum.

Namun, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan pengguna, kualitas input data, kestabilan infrastruktur, dan kemampuan sistem beradaptasi dengan proses nyata di klinik.

Strategi yang paling tepat adalah menerapkan sistem secara bertahap melalui Minimum Viable Product, mengujinya pada satu klinik, kemudian melakukan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi pengguna.

## 8. Fishbone Analysis

### 8.1 Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dianalisis menggunakan Fishbone Diagram adalah:

**Pelayanan kesehatan dan perawatan kelinci belum terintegrasi, kurang efisien, dan berisiko menyebabkan jadwal perawatan terlewat.**

Akar permasalahan dikelompokkan ke dalam enam kategori:

1. People.
  2. Process.
  3. Technology.
  4. Data.
  5. Management and Measurement.
  6. Environment and External Services.
- 

## 8.2 Faktor People atau Manusia

Permasalahan yang berasal dari manusia meliputi:

- Pemilik lupa jadwal perawatan.
- Admin harus menangani booking melalui beberapa kanal.
- Dokter harus mencari catatan pasien secara manual.
- Groomer tidak selalu memperoleh informasi medis pasien.
- Petugas dapat melakukan kesalahan pencatatan.
- Kemampuan penggunaan teknologi berbeda-beda.
- Tanggung jawab input data belum ditentukan secara jelas.
- Petugas mungkin tidak konsisten memperbarui status pelayanan.

### Akar penyebab

- Belum ada sistem reminder otomatis.
  - Belum tersedia standar pembagian tanggung jawab.
  - Belum ada pelatihan sistem.
  - Proses masih bergantung pada ingatan individu.
  - Tidak tersedia validasi dan field wajib.
- 

## 8.3 Faktor Process atau Metode

Permasalahan proses meliputi:

- Booking dilakukan melalui WhatsApp atau telepon.
- Konfirmasi jadwal dilakukan manual.
- Check-in belum terhubung dengan antrian.
- Status booking tidak tercatat secara konsisten.
- Hasil grooming dan pemeriksaan tidak saling terhubung.
- Rujukan groomer kepada dokter disampaikan secara lisan.
- Reminder dilakukan secara manual.
- Penyusunan laporan membutuhkan rekap ulang.

### **Akar penyebab**

- Belum tersedia standard operating procedure berbasis sistem.
  - Tidak ada workflow terintegrasi.
  - Tidak ada mekanisme slot locking.
  - Tidak ada status pelayanan standar.
  - Tidak ada proses otomatis untuk reminder dan laporan.
- 

## **8.4 Faktor Technology atau Mesin**

Permasalahan teknologi meliputi:

- Belum tersedia aplikasi terpusat.
- Jadwal belum dapat dilihat secara real-time.
- Tidak tersedia API untuk menghubungkan modul.
- Belum ada sistem notifikasi otomatis.
- Belum ada database pasien terpusat.
- Belum ada audit log.
- Belum ada sistem backup otomatis.
- Klinik bergantung pada perangkat dan koneksi internet.

### **Akar penyebab**

- Proses sebelumnya dirancang untuk pelayanan manual.
  - Belum dilakukan investasi infrastruktur.
  - Belum tersedia arsitektur sistem.
  - Belum ada pemisahan frontend, backend, dan database.
  - Belum ada integrasi dengan notification provider.
- 

## **8.5 Faktor Data atau Material**

Permasalahan data meliputi:

- Data pemilik dapat tercatat lebih dari satu kali.
- Data kelinci tidak memiliki ID unik.
- Riwayat kesehatan dapat terpisah.
- Data vaksinasi tidak terstruktur.
- Catatan grooming tidak selalu disimpan.
- Bukti pembayaran dapat hilang.
- Format pencatatan berbeda antarpetugas.
- Data lama mungkin tidak lengkap.

### **Akar penyebab**

- Tidak tersedia database terpusat.

- Tidak ada aturan validasi data.
  - Tidak ada standar field data.
  - Tidak ada nomor rekam medis unik.
  - Belum tersedia kebijakan migrasi data.
- 

## 8.6 Faktor Management and Measurement

Permasalahan manajemen dan pengukuran meliputi:

- Manajer tidak dapat melihat data operasional secara langsung.
- Tidak tersedia indikator kinerja pelayanan.
- Jumlah no-show sulit dihitung.
- Efektivitas reminder tidak diketahui.
- Pendapatan setiap layanan harus direkap ulang.
- Tidak ada pengukuran waktu check-in.
- Tidak ada pemantauan penggunaan sistem.

### Akar penyebab

- Tidak tersedia dashboard.
  - Tidak ada sistem pelaporan otomatis.
  - KPI belum ditentukan.
  - Data pelayanan belum terstruktur.
  - Tidak ada mekanisme monitoring dan analitik.
- 

## 8.7 Faktor Environment and External Services

Permasalahan lingkungan dan sistem eksternal meliputi:

- Koneksi internet dapat terganggu.
- Provider WhatsApp atau email dapat mengalami gangguan.
- Jadwal dokter dapat berubah mendadak.
- Pemilik tidak selalu membuka notifikasi.
- Perangkat petugas mungkin terbatas.
- Biaya penggunaan layanan eksternal dapat meningkat.

### Akar penyebab

- Ketergantungan pada pihak ketiga.
  - Tidak tersedia kanal notifikasi alternatif.
  - Tidak ada prosedur reschedule otomatis.
  - Tidak ada mekanisme retry.
  - Belum tersedia prosedur darurat ketika sistem tidak dapat digunakan.
-

## 9. Representasi Fishbone

### PEOPLE

- Pemilik lupa jadwal
- Petugas salah input
- Kemampuan digital berbeda
- Tanggung jawab belum jelas

### PROCESS

- Booking manual
- Status tidak baku
- Reminder manual
- Rujukan secara lisan

> PELAYANAN RABBIT CLINIC

### TECHNOLOGY

- Belum ada aplikasi
- Tidak ada database
- Tidak ada reminder
- Tidak ada audit log

/ BELUM TERINTEGRASI,  
KURANG EFISIEN, DAN  
PERAWATAN DAPAT TERLEWAT

### DATA

- Data tersebar
- Data ganda
- Riwayat tidak lengkap
- Tidak ada ID unik

### MANAGEMENT

- Tidak ada KPI
- Laporan manual
- Tidak ada dashboard
- Evaluasi lambat

### ENVIRONMENT

- Internet terganggu
- Provider gagal
- Jadwal berubah
- Perangkat terbatas

## 10. Source Code PlantUML Fishbone Diagram

Source code berikut dapat digunakan untuk menampilkan Fishbone Analysis secara visual melalui PlantUML.

```

@startuml
title Fishbone Analysis - Rabbit Clinic and Care
left to right direction

skinparam rectangle {
    RoundCorner 15
}

rectangle "PEOPLE" as People
rectangle "Pemilik lupa jadwal\nPetugas salah input\nKemampuan digital berbeda\nTanggung jawab belum jelas" as PeopleCause

rectangle "PROCESS" as Process
rectangle "Booking masih manual\nStatus pelayanan tidak baku\nReminder dilakukan manual\nRujukan disampaikan lisan" as ProcessCause

rectangle "TECHNOLOGY" as Technology
rectangle "Belum ada aplikasi terpusat\nBelum ada database terintegrasi\nTidak ada audit log\nBelum ada notifikasi otomatis" as TechnologyCause

rectangle "DATA" as Data
rectangle "Data tersebar\nData pasien ganda\nRiwayat tidak lengkap\nTidak ada ID pasien unik" as DataCause

rectangle "MANAGEMENT & MEASUREMENT" as Management
rectangle "Tidak ada dashboard\nLaporan dibuat manual\nKPI belum ditentukan\nEvaluasi operasional lambat" as ManagementCause

rectangle "ENVIRONMENT & EXTERNAL" as Environment
rectangle "Internet dapat terganggu\nProvider notifikasi dapat gagal\nJadwal dokter berubah\nPerangkat terbatas" as EnvironmentCause

rectangle "MASALAH UTAMA\nPelayanan Rabbit Clinic belum terintegrasi,\nkurang efisien, dan jadwal perawatan\nberisiko terlewat" as Problem

People --> PeopleCause
PeopleCause --> Problem

Process --> ProcessCause
ProcessCause --> Problem

Technology --> TechnologyCause
TechnologyCause --> Problem

Data --> DataCause
DataCause --> Problem

```

```
Management --> ManagementCause
ManagementCause --> Problem

Environment --> EnvironmentCause
EnvironmentCause --> Problem

@enduml
```

## 11. Prioritas Akar Masalah

| Prioritas | Akar Masalah                           | Alasan                                          |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1         | Tidak tersedia database terpusat       | Menjadi dasar seluruh profil dan riwayat pasien |
| 2         | Booking dan jadwal masih manual        | Menimbulkan risiko double booking               |
| 3         | Riwayat medis tidak terintegrasi       | Mempengaruhi kualitas pemeriksaan               |
| 4         | Reminder masih dilakukan manual        | Menyebabkan jadwal kontrol terlewat             |
| 5         | Tidak ada standar status pelayanan     | Menyulitkan pemantauan pasien                   |
| 6         | Billing tidak terintegrasi             | Menimbulkan risiko kesalahan transaksi          |
| 7         | Hak akses belum dibedakan              | Meningkatkan risiko keamanan data               |
| 8         | Pengguna belum terlatih                | Dapat menghambat implementasi                   |
| 9         | Belum tersedia laporan otomatis        | Memperlambat pengambilan keputusan              |
| 10        | Ketergantungan pada provider eksternal | Dapat mengganggu notifikasi dan pembayaran      |

## 12. Rekomendasi Perbaikan

### 12.1 Jangka Pendek

Perbaikan jangka pendek berfokus pada pembuatan Minimum Viable Product yang mencakup:

- Registrasi dan login.
- Profil pemilik.
- Profil kelinci.
- Jadwal dokter dan groomer.
- Booking layanan.
- Check-in dan antrean.
- Rekam medis.



- Catatan grooming.
- Tagihan sederhana.
- Reminder dasar.

## 12.2 Jangka Menengah

Pengembangan jangka menengah meliputi:

- Reschedule dan pembatalan booking.
- Audit log.
- Dashboard manajemen.
- Laporan kunjungan dan pendapatan.
- Retry notifikasi.
- Grafik berat badan.
- Pengiriman bukti pembayaran.
- Migrasi data pasien lama.

## 12.3 Jangka Panjang

Pengembangan jangka panjang dapat mencakup:

- Multi-cabang.
- Payment gateway.
- Mobile application.
- Telemedicine.
- Modul rawat inap.
- Modul laboratorium.
- Loyalty program.
- Integrasi dengan pet shop.
- Analitik bisnis.
- Integrasi perangkat pemantauan kesehatan.

# 13. Rencana Penutupan Gap

| Gap                         | Tindakan Perbaikan               | Output yang Diharapkan          |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data tersebar               | Membangun database terpusat      | Single source of truth          |
| Booking manual              | Membuat modul booking            | Booking terdokumentasi          |
| Jadwal bentrok              | Slot locking dan validasi jadwal | Tidak terjadi double booking    |
| Riwayat medis terpisah      | Membuat Medical Record Service   | Riwayat pasien mudah ditelusuri |
| Grooming tidak terintegrasi | Membuat Grooming Service         | Temuan grooming tercatat        |

| Gap                      | Tindakan Perbaikan                   | Output yang Diharapkan           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Reminder manual          | Scheduler dan Notification Service   | Reminder dikirim otomatis        |
| Tagihan manual           | Billing Service                      | Perhitungan lebih akurat         |
| Akses tidak terbatas     | Role-based access control            | Data lebih aman                  |
| Perubahan tidak terlacak | Audit log                            | Perubahan dapat ditelusuri       |
| Laporan manual           | Dashboard dan report module          | Evaluasi operasional lebih cepat |
| Pengguna belum siap      | Pelatihan dan pilot testing          | Adopsi pengguna meningkat        |
| Risiko provider gagal    | Retry dan multi-channel notification | Keandalan notifikasi meningkat   |

## 14. Indikator Keberhasilan Penutupan Gap

Penutupan gap dapat dinilai berhasil apabila:

1. Seluruh pasien baru memiliki profil digital.
2. Setiap kelinci memiliki ID pasien unik.
3. Minimal 80% booking dilakukan melalui sistem.
4. Tidak terjadi double booking.
5. Minimal 90% pemeriksaan tersimpan secara digital.
6. Setiap layanan memiliki status yang dapat dipantau.
7. Reminder dibuat otomatis dari hasil pelayanan.
8. Seluruh transaksi memiliki bukti pembayaran.
9. Dokter dapat membuka riwayat pasien sebelum pemeriksaan.
10. Groomer dapat mencatat temuan dan rujukan.
11. Manajer dapat melihat laporan tanpa rekap manual.
12. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya.

## 15. Kesimpulan

Gap analysis menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar Rabbit Clinic and Care terletak pada integrasi data, pengelolaan booking, penyimpanan riwayat kesehatan, reminder perawatan, billing, dan pengendalian akses pengguna.

Hasil SWOT menunjukkan bahwa fokus khusus pada kelinci dan integrasi layanan merupakan kekuatan utama RabbitCare. Kelemahan utamanya adalah sistem masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kesiapan pengguna serta infrastruktur.

Fishbone Analysis menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya berasal dari teknologi, tetapi juga dari manusia, metode kerja, kualitas data, manajemen, dan lingkungan eksternal.

Dengan demikian, solusi tidak cukup hanya berupa pembangunan aplikasi. Implementasi RabbitCare juga harus disertai standarisasi proses, pembagian tanggung jawab, pelatihan pengguna, validasi data, serta evaluasi secara bertahap melalui pilot testing.